

Sostenere la persona autistica monotropica lungo l'arco di vita

Una guida per pratici e professionisti sanitari

Scopo. Questa guida spiega cos'è una mente autistica monotropica, come le sue caratteristiche cambiano lungo l'arco di vita e come pratici e professionisti sanitari possano **interagire con, stimolare (coinvolgere) e sostenere** le persone autistiche dalla prima infanzia alla vecchiaia. Si fonda sulla teoria del **monotropismo** dell'autismo — un resoconto basato sull'attenzione e affermando la neurodivergenza, sviluppato dai ricercatori autistici Dinah Murray, Wenn Lawson e Mike Lesser (2005) — e sull'evidenza sottoposta a revisione paritaria e sulle linee guida cliniche/di pratica dove esistono. Non sostituisce una valutazione individualizzata; ogni persona autistica è diversa.

Una nota sul linguaggio. Questa guida usa il **linguaggio con l'identità per prima** ("persona autistica"), che è la preferenza della maggioranza della comunità autistica ed è coerente con la teoria di fonte. Alcuni individui e famiglie preferiscono il linguaggio persona-prima ("persona con autismo"); seguite la preferenza dell'individuo. La guida evita deliberatamente i termini basati sul deficit ("disordinato", "deficiente", "sintomo") tranne quando cita criteri clinici, e descrive invece differenze con punti di forza e sfide. Il monotropismo è una lente; una minoranza di persone autistiche non sente che le descrive, e dovrebbe integrare, non sostituire, l'ascolto dell'individuo.

Parte 1 — Cos'è una mente autistica monotropica?

Il monotropismo propone che le menti funzionino come un **sistema di interessi**: siamo attratti da molte cose, questi interessi richiamano la nostra attenzione, e **l'attenzione è una risorsa limitata** per cui i processi mentali competono (Murray, Lesser & Lawson, 2005). La differenza tra cognizione autistica e non-autistica è inquadrata come una differenza in *come l'attenzione è allocata*, non un deficit.

"In ogni singolo momento, la quantità di attenzione disponibile a un individuo cosciente è limitata. C'è competizione tra i processi mentali per questa risorsa scarsa." — Murray, Lesser & Lawson (2005), via la National Autistic Society (NAS, 2025).

Una **mente monotropica** tende ad attivare **meno interessi contemporaneamente**, ma ogni interesse attivo cattura una quota **sproporzionata e intensa** delle risorse di elaborazione, producendo un **"tunnel di attenzione"** ristretto e profondo. Tutto ciò che è fuori dal tunnel viene elaborato al minimo. Una mente **politropica** (la modalità non-autistica più comune) distribuisce l'attenzione su più interessi e passa tra loro più fluidamente (Murray, Lesser & Lawson, 2005; F. Murray, 2018).

La teoria fa tre previsioni centrali che si mappano sull'esperienza autistica quotidiana (F. Murray, 2018; Dwyer, 2025; NAS, 2025):

1. **Intensità dentro il tunnel** — focalizzazione vivida e profonda che supporta competenza, creatività e stati di **flusso**.
2. **Elaborazione ridotta fuori dal tunnel** — stimoli, segnali sociali e persino segnali interni (fame, dolore, bisogni del bagno) possono non registrarsi.
3. **Difficoltà a spostarsi** — le transizioni tra stati attentivi sono lente e faticose; questa è l'**inerzia autistica**.

1.1 Il profilo caratteristico a colpo d'occhio

Dominio	Caratteristica informata dal monotropismo
Attenzione / interesse	Focalizzazione profonda e ristretta; poche tracce simultanee; gli "interessi speciali" sono centrali, gioiosi e significativi, non periferici

Dominio	Caratteristica informata dal monotropismo
Sensoriale	Iper-responsività (uno stimolo intrusivo catturato nel tunnel è sentito intensamente); ipo-responsività (quando si è assorti altrove, stimoli/dolore possono non registrarsi); ricerca sensoriale (uno stimolo piacevole nel tunnel inseguito intensamente) — una spiegazione <i>unificata</i>
Interocezione e corpo	Consapevolezza ridotta di fame, sete, dolore, fatica, bisogni del bagno quando si è in flusso ("disconnessione interoettiva")
Spostamento / funzione esecutiva	Inerzia autistica — difficoltà a iniziare, fermare o cambiare binario; non una generica "disfunzione esecutiva"
Sociale / comunicazione	L'elaborazione sociale multicanale è costosa; interpretazione letterale; bisogno di tempo di elaborazione; il problema della doppia empatia significa che l'incomprensione è <i>bidirezionale</i> , non un deficit autistico
Routine e stimming	Le routine riducono le decisioni in competizione e il carico mentale; lo stimming fornisce input prevedibile e auto-controllato che filtra il sovraccarico e ripristina l'equilibrio
Punti di forza	Competenza, ricerca di pattern, concentrazione sostenuta, flusso, onestà, profondità di conoscenza, immersione creativa

1.2 I rischi per il benessere che ne conseguono

Capire il *meccanismo* rende i rischi prevedibili e — cosa cruciale — prevenibili:

- **Split monotropico** (termine coniato da Tanya Adkin): la dissonanza mentale e il depauperamento dall'essere costretti a dividere o spostare rapidamente l'attenzione in modi politropici; "può avere effetti disastrosi sia nel breve che nel lungo termine" (F. Murray, 2023).
- **Meltdown e shutdown** sono risposte **involontarie** del sistema nervoso al sovraccarico, non scelte comportamentali o "capricci". Un **meltdown** è visibile (pianto, urla, andirivieni, stimming, tentativi di fuga); uno **shutdown** è lo specchio internalizzato — ritiro, mancanza di risposta, disimpegno, uno "spegnimento" protettivo per conservare energia (Autism Society, 2025; Leicestershire Partnership NHS Trust; Reframing Autism). Entrambi richiedono sostanziale **tempo di recupero** (a volte giorni) e sono aggravati dalla mancanza di comprensione degli altri.

- Il **burnout autistico** è "una sindrome ... risultante da stress di vita cronico e un mancato adattamento tra aspettative e capacità senza supporti adeguati", caratterizzata da **esaurimento pervasivo e a lungo termine (tipicamente 3+ mesi), perdita di funzione e ridotta tolleranza agli stimoli** (Raymaker et al., 2020). È **distinto dal burnout occupazionale e dalla depressione clinica**, è legato al **comportamento suicidario**, ed è aggravato dall'essere insegnati a **mascherare/camuffare** i tratti autistici. Il recupero è associato ad **accettazione e supporto sociale, congedo / aspettative ridotte, e "fare le cose a modo autistico" / rimozione della maschera** (Raymaker et al., 2020).
- Il **masking / camuffamento** (nascondere i tratti autistici per apparire non-autistici) è estenuante ed è associato ad ansia, depressione e diagnosi mancata — in particolare tra ragazze e donne, a cui più spesso si insegna socialmente a mascherare (F. Murray, 2023; Pearson & Rose, 2021; Bradley et al., 2021).
- **Ruminazione / "loop di preoccupazione"**: lo stesso tunneling che produce interesse profondo può fissarsi su preoccupazioni e ansie (Hallett, 2021; F. Murray, 2023).

1.3 Status dell'evidenza (siate onesti con voi stessi e con i clienti)

Il monotropismo risuona fortemente con l'esperienza vissuta autistica ed è sempre più citato nella ricerca, ma rimane una teoria **descrittiva** con test sperimentale diretto limitato e una base di misurazione immatura — il **Monotropism Questionnaire** (Garau et al., 2023) è l'unico strumento dedicato ed è ancora in maturazione (Dwyer, 2021; Dwyer, 2025). L'evidenza convergente di supporto include il disimpegno dell'attenzione "vischioso" / rallentato nei bambini autistici (Landry & Bryson, 2004; meta-analisi: Sacrey et al., 2015) e una letteratura emergente sul **flusso autistico** (Heasman et al., 2024). Trattate il monotropismo come una potente *euristica clinica* — non un'etichetta diagnostica.

Parte 2 — Principi trasversali per ogni praticante

Prima delle sezioni per età, questi principi si applicano **a ogni tappa di vita e in ogni contesto**. Sono il nucleo pratico di "come interagire con e gestire" bene una persona monotropica.

1. **Incontratela dove è la sua attenzione.** L'implicazione pratica più citata del monotropismo è lavorare *con* l'interesse attuale della persona piuttosto che contro. Gli interessi sono "leva", non ostacoli da reindirizzare (F. Murray, 2018; Wood, 2019; Lawson). *"Trattate gli interessi come qualcosa con cui lavorare"* (F. Murray, 2018).
2. **Proteggere il tunnel di attenzione; minimizzare lo "split monotropico".** Evitate interruzioni, cambio rapido forzato di compiti e multitasking non necessario. Dove uno spostamento è inevitabile, date **avvisi e tempo di transizione** (si veda §3). Come inquadra la pianificazione del posto di lavoro l'ingegnere autistico Jamie Knight: costruite **"tunnel non compiti"**, e lasciate che *l'ambiente apra uno spazio affinché il tunnel passi* piuttosto che costringere la persona a trapanarlo (Knight, 2021/2022).
3. **Rispettate gli interessi profondi come risorse di benessere.** Gli interessi speciali forniscono gioia, stabilità, identità, apprendimento e recupero dal burnout; non sono "ossessioni" da limitare (F. Murray, 2023; Mantzalas et al., 2022). Ridurne l'accesso è un rischio clinico, non una cura.
4. **Riducete il carico sensoriale non necessario** e progettate ambienti accessibili (meno rumore/disordine visivo; permettete spazi quieti in penombra; evitate abbagliamento fluorescente e odori forti dove possibile) (NAS, 2025; F. Murray, 2023).
5. **Comunicare in modo chiaro e letterale.** Dite ciò che intendete; evitate sarcasmo, richieste indirette e forte affidamento su solo tono/espressione; concedete **tempo extra di elaborazione**; offrite le informazioni per iscritto. Non equiparate una risposta lenta a disinteresse o mancanza di comprensione (F. Murray, 2023).
6. **Praticate la postura della doppia empatia.** Riconoscete che le rotture comunicative sono **bidirezionali** (Milton, 2012). Quando qualcosa va male nell'interazione, chiedetevi cosa *voi* potreste non cogliere, piuttosto che attribuirlo al deficit della persona autistica.
7. **Sostenete agency e autenticità; non forzate il masking.** Riducete la pressione a "passare" per non-autistico. Sopprimere gli stim o la comunicazione naturale è dannoso (F. Murray, 2023; Raymaker et al., 2020; Pearson & Rose, 2021).
8. **Costruite prevedibilità e routine con la persona, non su di lei.** Le routine imposte spesso si ritorcono contro; le routine co-create

riducono il carico decisionale e sono benvenute (F. Murray, 2022).

9. Pianificate il recupero. Dopo eventi ad alta domanda (visite cliniche, transizioni, richieste sociali), aspettatevi e permettete tempo libero, stimming e accesso agli interessi.

10. Ascoltate l'individuo come esperto della propria esperienza.

L'autovalutazione è prova primaria; il Monotropism Questionnaire (Garau et al., 2023) può essere un utile *avvio di conversazione*, non uno strumento diagnostico.

Parte 3 — La guida lungo l'arco di vita

Ogni sezione copre: **(a) cosa potreste osservare, (b) come interagire, (c) come stimolare / coinvolgere, e (d) come sostenere / gestire le sfide.**

3.1 Prima infanzia (circa 0–5 anni)

(a) Cosa potreste osservare. Focalizzazione intensa su oggetti/argomenti specifici; interessi intensi a insorgenza precoce (spesso prima che nei bambini non-autistici); allineare, ordinare, categorizzare e fare-pattern come gioco; attenzione congiunta e risposta al nome ridotte o atipiche; **disimpegno rallentato dell'attenzione** ("sguardo vischioso") — misurabile dall'infanzia e uno dei primi segni; iper- o ipo-responsività sensoriale; routine e gioco ripetitivo; meltdown alle transizioni. Un bambino monotropico può essere profondamente assorto e perdersi molto al di fuori del tunnel, inclusi fame, dolore o un genitore che lascia la stanza (Landry & Bryson, 2004; F. Murray, 2023; Donzelli, 2021; Lawson, sulla permanenza dell'oggetto).

(b) Come interagire. Entrate nel tunnel attento del bambino invece di tirarlo fuori — **inseritevi nel suo gioco e nel suo interesse per primi**, poi estendete gentilmente da lì. Usate l'interesse per costruire connessione e attenzione condivisa (Lawson). Tenete il linguaggio chiaro, lento e letterale; concedete tempo di elaborazione; non forzate il contatto visivo (il contatto visivo può esso stesso consumare scarse risorse attentive) (F. Murray, 2023). Riducete il carico sensoriale nella stanza.

(c) Come stimolare / coinvolgere. Usate l'**interesse intenso del bambino come ponte verso apprendimento e costruzione di competenze** — sequenziamento, linguaggio, conteggio, competenze motorie e di gioco si possono tutte praticare *attraverso* l'interesse (Lawson; Wood, 2019; BERA, sugli stati di flusso in classe). Sostenete l'emergere dell'**attenzione congiunta** attraverso gioco guidato dall'interesse e basato sulla relazione e intervento precoce (il modello JASPER e approcci simili basati su interesse/gioco mirano all'attenzione congiunta e al gioco simbolico; Kasari et al., 2006). Onorate la **cultura del gioco autistico** — allineare, ordinare e l'esplorazione sensoriale sono gioco valido, non gioco "sbagliato" da correggere (Donzelli, 2021).

(d) Come sostenere / gestire. Gestite le **transizioni** con agende visive/timer, conteggi alla rovescia, avvisi verbali + visivi *prima* del cambio, oggetti "ponte" da un'attività alla successiva e tempo extra; non strappate mai bruscamente un bambino fuori da un tunnel di attenzione (Autism Little Learners; F. Murray, 2023). Per i **meltdown**: restate calmi, riducete la stimolazione, non giudicate e non punite — sono involontari; assicurate la sicurezza, poi permettete il recupero (Autism Society, 2025). Proteggete l'accesso allo stimming (è autoregolazione) (F. Murray, 2023). Evitate programmi basati sulla compliance che addestrano via gli stimoli o i comportamenti naturali: questi aumentano il masking e il danno a lungo termine (F. Murray, 2023; Raymaker et al., 2020).

3.2 Infanzia in età scolare (circa 6–12 anni)

(a) Cosa potreste osservare. La scuola è spesso la prima prova di stress prolungata di un sistema monotropico ed è "un inferno per molti bambini monotropici — anche se molti di noi amano imparare" (F. Murray, 2023). L'aula, i corridoi e gli intervalli sono tipicamente **troppo rumorosi, troppo pieni di stimoli visivi e troppo imprevedibili**, consumando attenzione che dovrebbe andare all'apprendimento. I bambini possono sembrare "comportarsi male" alle transizioni, ritirarsi agli intervalli, essere bullizzati per interessi "strani" o gioco autodiretto, o essere fraintesi dal personale come sfidanti, pigri o disinteressati. L'inerzia si manifesta come difficoltà a iniziare il lavoro, cambiare materia o fare la borsa. Alcuni bambini iniziano qui a mascherare pesantemente, con costi di salute mentale (F. Murray, 2023; Leatherland, 2019; NAS, 2025).

(b) Come interagire (insegnanti, infermieri scolastici, terapeuti).

Riconoscete che la resistenza alle transizioni è un problema di **costo cognitivo**, non sfida. Fornite spazi quieti/in penombra (es. "incarichi" in biblioteca all'intervallo, un angolo calmo). Costruite relazioni attraverso l'interesse del bambino. Comunicate alla lettera, in anticipo e per iscritto dove possibile. Siate modello della postura della doppia empatia per pari e colleghi — inquadrate le differenze come differenze, non deficit (F. Murray, 2023; Wood, 2019).

(c) Come stimolare / coinvolgere (il "curricolo monotropico").

Rendete **l'interesse speciale la spina dorsale dell'apprendimento**: insegnate lettura, scrittura, matematica, storia e scienze *attraverso* l'interesse; permettete tempo esteso nel flusso guidato dall'interesse; progettate compiti attorno a meno tracce più profonde invece del cambio costante (Wood, 2019, "interessi intensi ... la chiave per l'inclusione educativa"; F. Murray, "Monotropism at School", 2019; BERA). Gli stati di flusso sono stati di apprendimento — proteggeteli: *"se uno studente si sente sovraccarico ... e sapete che ha un interesse monotropico per i Lego, perché non creare uno spazio quiete ... e permettergli tempo esteso?"* (BERA). Connettetevi con uno studente autistico appassionato *attraverso* la passione (Wood et al., 2022; Lawson).

(d) Come sostenere / gestire. Usate agende visive, avvisi di transizione e attività-ponte; date tempo di transizione generoso e riducete il numero di transizioni al giorno dove possibile (Autism Little Learners; F. Murray, 2023). Co-create le routine *con* il bambino. State attenti al **burnout autistico e alla "regressione delle competenze"** nei bambini in età scolare — questi spesso riflettono sovraccarico e uno spostamento nelle risorse attentive, non perdita di abilità innata, e la risposta è **ridurre le richieste e ripristinare l'accesso a interessi/riposo**, non spingere di più (Edgar, 2024; Raymaker et al., 2020). Identificate e riducete la pressione al masking, specialmente nelle ragazze, a cui la diagnosi manca spesso perché mascherano (F. Murray, 2023). Usate una guida per insegnanti sul burnout (es. Edgar, 2023) e consultate i genitori come esperti del proprio bambino.

3.3 Adolescenza (circa 13–18 anni)

(a) Cosa potreste osservare. La pubertà porta cambiamenti ormonali e cerebrali (potatura sinaptica, mielinizzazione) che possono intensificare le risposte sensoriali ed emotive e disruptare un equilibrio stabilito. Le richieste sociali dell'adolescenza — gerarchie tra pari che si spostano, regole sociali implicite, frequentazioni, formazione dell'identità — sono estremamente ad alto canale ed estenuanti per un sistema monotropico. Le difficoltà di salute mentale (ansia, depressione) qui raggiungono il picco; la ruminazione / i "loop di preoccupazione" possono radicarsi; il camuffamento si intensifica, e molte ragazze autistiche e giovani di genere marginalizzato sono **identificati per la prima volta solo in crisi**. Gli interessi speciali diventano centrali per l'identità e il recupero. Le amicizie, quando di alta qualità, sono protettive per la salute mentale (ARI, sulla pubertà; Autism Awareness Australia; F. Murray, 2023; Hallett, 2021; Sedgewick/Cook et al., via PMC9597130).

(b) Come interagire. Trattate il giovane come esperto della propria esperienza. Usate comunicazione chiara, letterale e rispettosa; date tempo di elaborazione e opzioni scritte. Validate gli interessi come legittimi e formativi dell'identità. Siate attenti al problema della doppia empatia nelle interazioni con pari e clinici. Fornite **prevedibilità** attorno agli appuntamenti e riducete il carico sociale/sensoriale non necessario (Autism Awareness Australia; F. Murray, 2023).

(c) Come stimolare / coinvolgere. Incanalate gli interessi speciali in **studio, progetti, portfolio, volontariato ed esplorazione professionale precoce** — sono la più grande risorsa motivazionale e di costruzione di competenze dell'adolescente. Sostenete **identità e comunità**: gruppi tra pari autistici, club di interessi speciali, mentor e comunità autistiche online possono trasformare il benessere. Insegnate l'**auto-comprensione** del monotropismo affinché il giovane possa difendere i propri bisogni attenti (anziché interiorizzare "sono pigro/rotto").

(d) Come sostenere / gestire. Affrontate proattivamente la **salute mentale**; fate screening per ansia, depressione, burnout e suicidalità, riconoscendo che il **burnout autistico è distinto dalla depressione** e dal burnout occupazionale e richiede *richieste ridotte, accettazione e rimozione della maschera*, non solo CBT o antidepressivi (Raymaker et al., 2020). Sostenete i bisogni pratici e sensoriali legati alla pubertà

(mestruazione, igiene, cambiamenti corporei) esplicitamente e concretamente (ARI). Affrontate il **danno del camuffamento** — riducete esplicitamente l'aspettativa di mascherare. Insegnate l'autogestione di meltdown/shutdown e assicurate che il giovane abbia una via di recupero a bassa domanda. Pianificate le **transizioni all'età adulta** (istruzione, lavoro, passaggio sanitario) presto e con gli interessi del giovane al centro. *(Inferenza, segnalata: gran parte della guida clinica qui è estrapolata dalla letteratura adulta su burnout/masking e dai resoconti di esperienza vissuta autistica più che da RCT specifici sull'adolescenza.)*

3.4 Età adulta (circa 19–mezza età)

(a) Cosa potreste osservare. Molti adulti autistici — specialmente donne, persone di colore e quelli senza disabilità intellettiva — sono **diagnosticati solo in età adulta** (la "generazione perduta", Lai & Baron-Cohen). Nell'ambiente giusto, gli adulti monotropici portano **competenza profonda, concentrazione sostenuta, affidabilità, rilevamento di pattern e onestà** che sono risorse genuine. Nell'ambiente sbagliato — uffici open-space, interruzioni costanti, aspettative poco chiare, carico sensoriale, richieste socio-politiche — affrontano depauperamento cronico, masking, meltdown/shutdown e **burnout autistico** (Knight, 2021/2022; Booth, 2021; Raymaker et al., 2020; Mantzalas et al., 2022).

(b) Come interagire. Comunicate **esplicitamente e per iscritto**; definite aspettative, scadenze e norme sociali concretamente piuttosto che implicarle. Permettete comunicazione scritta/asincrona (email, testo) che riduce il carico di canale. Date tempo di elaborazione; non leggete una pausa come resistenza. Chiedete alla persona cosa l'aiuta — è l'esperta (F. Murray, 2023; Knight, 2021).

(c) Come stimolare / coinvolgere (posto di lavoro). Strutturate il ruolo attorno a **pochi "tunnel più profondi, non compiti"** (Knight, 2021): riducete al minimo riunioni e interruzioni, raggruppate il lavoro superficiale, permettete tempo di flusso e date accesso a spazio quiete/controllato sensorialmente. Abbinare i compiti a **punti di forza e interessi speciali**; l'intensità della focalizzazione autistica, quando protetta, è una grande risorsa di produttività e innovazione (Advanced Autism Services, 2025; Sachs Center; Booth, 2021). Costruite **routine** con l'adulto e usate gli adattamenti legalmente disponibili (es. ADA/Legge

sull'uguaglianza) (Links ABA). Incoraggiate il **"vivere poco"** dove utile — semplificare la vita in poche aree di focus può migliorare marcatamente funzione e felicità (Knight, 2021).

(d) Come sostenere / gestire. Trattate il **burnout autistico** come un'entità clinica seria e distinta: riconoscete esaurimento cronico, perdita di competenze precedentemente detenute e ridotta tolleranza agli stimoli; valutate la suicidalità (Raymaker et al., 2020). La direzione di recupero supportata dall'evidenza è **ridurre richieste e aspettative, fornire accettazione e supporto sociale, e permettere "fare le cose a modo autistico" / rimozione della maschera** (Raymaker et al., 2020; Mantzalas et al., 2022). *Non* prescrivete training delle abilità sociali basato sul masking come soluzione. Affrontate le condizioni co-occorrenti di ansia, depressione, ADHD, sonno e gastrointestinali (più comuni negli adulti autistici). Rispettate che gli **interessi speciali sono protettivi e ricostituenti**, non compulsioni da limitare (Mantzalas et al., 2022).

3.5 Adulti più anziani e anziani (circa 60+)

(a) Cosa potreste osservare — e gli onesti limiti della nostra conoscenza. Questa è la **parte meno studiata dell'arco di vita autistico**: al 2024, la ricerca sugli adulti autistici più anziani rappresentava solo circa lo **0,4% della letteratura sull'autismo** (pur crescendo ~392% dal 2012) (Klein et al., 2024). L'evidenza esistente è preoccupante: gli esiti per gli adulti autistici più anziani sono **generalmente scadenti** in tutti e quattro i domini dell'"invecchiare bene" (salute e funzionamento; funzionamento cognitivo e fisico; affetto positivo e controllo; partecipazione sociale). Mostrano **aumento delle condizioni mediche, basse capacità adattive, rischio elevato di declino cognitivo, limitata attività fisica, alti tassi di condizioni di salute mentale, bassa qualità della vita e ridotta partecipazione sociale/di comunità** (Klein et al., 2024). In un campione australiano (età 40+), solo il **3,3% soddisfaceva i criteri per "invecchiamento di successo"** (Klein et al., 2024). Gli adulti autistici più anziani hanno **tassi più alti della maggior parte delle condizioni di salute** — disturbi dell'umore, problemi di sonno, condizioni gastrointestinali e cardiache — dei coetanei non-autistici (Additude, che riassume studi di popolazione). Molti adulti autistici più anziani sono **non diagnosticati**

("generazione perduta"); i clinici devono essere pronti a riconoscere l'autismo in adulti più anziani che si presentano con differenze sociali/sensoriali lifelong, burnout o crisi di salute mentale (OAR; Klein et al., 2024).

(b) Come interagire. Tutti i principi trasversali si applicano con peso extra: comunicazione chiara, letterale e rispettosa; concedete ampio tempo di elaborazione e informazioni scritte; riducete il carico sensoriale (i cambiamenti di udito e visione si sommano alle differenze sensoriali di base); non presumete mai incapacità cognitiva da una risposta lenta o atipica. Tenete conto del **problema della doppia empatia** esplicitamente nei contesti di cura.

(c) Come stimolare / coinvolgere. Conservate e **proteggete gli interessi speciali e le routine lifelong** — sono ancora di identità, cognizione e benessere, e possono essere specialmente protettive mentre altre capacità cambiano. Adattate le attività alle **capacità fisiche e sensoriali che cambiano** invece di rimuoverle. Sostenete la **comunità e la connessione autistica** per contrastare la grave isolamento sociale visto in questo gruppo (Klein et al., 2024; OAR). Incoraggiate attività fisica dolce tarata sulla persona (l'inattività fisica è un problema identificato) (Klein et al., 2024).

(d) Come sostenere / gestire.

- **L'accesso all'assistenza sanitaria** è una lacuna critica: molti adulti autistici più anziani evitano le cure a causa di esperienze negative lifelong e barriere sensoriali/comunicative; le cliniche hanno bisogno di formazione (OAR; si veda Parte 4).
- State attenti al **burnout autistico** — il rischio si accumula attraverso decenni di masking e bisogni non soddisfatti, e può essere frainteso come depressione o "declino legato all'età" (Raymaker et al., 2020).
- Siate all'erta al **cambiamento cognitivo vs differenza autistica**: distinguere i pattern monotropici/di inerzia autistici dalla vera **demenza/declino cognitivo** è clinicamente difficile e poco studiato; non presupponete. C'è *ricerca molto limitata* su autismo + demenza/Alzheimer — segnalate l'incertezza e valutate attentamente (ABTAB; Klein et al., 2024).
- Gli **ambienti di cura** (RSA, ospedali) sono spesso ostili sensorialmente e dirompenti per la routine; fate pressione per spazi quieti, routine

prevedibili, conservazione di oggetti/interessi significativi e formazione del personale sull'autismo.

- Sostenete la **fine vita e la pianificazione anticipata** con comunicazione chiara e letterale e rispetto dell'autonomia.
- *Inferenza, segnalata*: Poiché l'evidenza specifica sull'autismo in vecchiaia è scarsa, gran parte di questa sezione applica il modello di monotropismo lungo l'arco di vita più i risultati generali sull'invecchiamento-con-autismo; trattate come guida di buona pratica, non protocollo stabilito.

Parte 4 — Guida specifica per i professionisti sanitari

I contesti sanitari (luci fluorescenti brillanti, attese imprevedibili, istruzioni vaghe, richieste sensoriali e sociali, dolore e invasività) sono tra gli ambienti più difficili per le persone monotropiche e scatenano spesso shutdown, meltdown ed evitamento delle cure (Autism Society, 2025; revisione narrativa PMC11305600 sull'assistenza sanitaria amica dell'autismo). Quanto segue è tratto dalla letteratura sull'assistenza sanitaria amica dell'autismo e dall'**AASPIRE Healthcare Toolkit / Autism Healthcare Accommodations Tool (AHAT)** (autismandhealth.org).

Prima della visita

- **Offrite un questionario pre-visita / l'AHAT** per cogliere i bisogni sensoriali, comunicativi e procedurali specifici dell'individuo e produrre un report personalizzato degli adattamenti (AASPIRE).
- **Fornite informazioni scritte e letterali** su cosa accadrà, in che ordine e quanto durerà; offrite foto della stanza/personale se possibile.
- **Offrite scelta di orario**: primo/ultimo appuntamento (i più quieti), attese più brevi, nessuna clinica rumorosa sovrapposta.
- Permettete alla persona di **portare un accompagnatore di fiducia** e il proprio **kit sensoriale** (cuffie antirumore, occhiali da sole, oggetti fidget) (CHOP; Grateful Care ABA).

Durante la visita

- **Riducete il carico sensoriale:** illuminazione soffusa o morbida dove possibile, minimizzate i bip, offrite una stanza quiete, evitate odori forti/profumo (Autism Spectrum News; CHOP).
- **Comunicate alla lettera e concretamente:** spiegate ogni passaggio *prima* di farlo; dite ciò che intendete; evitate le figure retoriche; verificate la comprensione chiedendo alla persona di parafrasare; **permettete lunghi silenzi per l'elaborazione.**
- **Non forzate il contatto visivo;** permettete alla persona di guardare altrove, fare stimming o comunicare per iscritto/digitazione/CAA.
- **Andate piano; offrite pause.** Tenete disponibile un kit di distrazione sensoriale (CHOP).
- **Rispettate il tunnel di attenzione:** se la persona usa un interesse o uno stim per autoregolarsi durante una procedura, non interrompetelo.
- Applicate la **postura della doppia empatia** (Milton, 2012; Neurodivergent Insights): se la comunicazione si blocca, presumete un divario *reciproco* e adattatevi, piuttosto che etichettare il paziente "difficile" o "non collaborante".

dopo la visita

- Fornite **follow-up scritto** (diagnosi, istruzioni, passi successivi) in linguaggio letterale.
- Inserite **tempo di recupero** e avvertite che la persona potrebbe aver bisogno di riposare/andare in shutdown dopo.
- Documentate gli adattamenti efficaci nella cartella affinché siano automatici la volta dopo.

Riconoscimenti clinicamente critici

- **Il burnout autistico non è depressione.** Si presenta come esaurimento cronico, perdita di competenze e ridotta tolleranza agli stimoli, guidato da carico cumulativo e un mancato adattamento aspettative-capacità; trattarlo come depressione (o spingere il paziente a "sforzarsi di più") può approfondirlo e rischiare suicidalità. Il recupero richiede richieste ridotte, accettazione e permesso di togliere la maschera (Raymaker et al., 2020).

- **Il masking in clinica è comune e costoso.** Un paziente che "sembra a posto" in un appuntamento di 15 minuti potrebbe star camuffando e pagandone il costo dopo; non lasciate che una presentazione mascherata sovrasti l'autovalutazione o l'anamnesi (Pearson & Rose, 2021; F. Murray, 2023).
- **Dolore e interocezione.** Una persona monotropica potrebbe non notare o segnalare dolore, fame, sete, fatica o sintomi interni se non quando gravi (Kelly Mahler, 2024; Lawson). Non equiparate il "non lamentarsi" al "non soffrire"; chiedete proattivamente, e considerate che i pattern sintomatici riportati possono essere ritardati o atipici.
- **Farmaci ed effetti collaterali.** Le persone autistiche riferiscono spesso risposte sensoriali ed emotive atipiche ai farmaci; iniziate bassi, titolate lentamente e monitorate attentamente l'autovalutazione.
- **Meltdown/shutdown in clinica.** Sono involontari: riducete la stimolazione, abbassate le richieste, assicurate la sicurezza, date tempo e spazio, non contenete e non punite; un ritiro/shutdown ha bisogno di pazienza calma e a basso input, non di pressione a "collaborare" (Autism Society, 2025; Leicestershire Partnership NHS Trust; Reframing Autism).
- **Consenso e capacità.** Fornite le informazioni in forma accessibile e letterale; concedete tempo di elaborazione e decision-making supportato; non presumete mai l'incapacità dalla comunicazione atipica.
- **Gli adattamenti aiutano tutti.** Una cura adatta ai sensi, prevedibile e chiaramente comunicata giova anche a pazienti con ADHD, PTSD, ansia, cali sensoriali, cambiamenti cognitivi e molti altri (UNC Health, 2025).

Parte 5 — Cosa evitare (danno comune)

- Tirare bruscamente una persona fuori da un tunnel di attenzione o interrompere il flusso ripetutamente (F. Murray, 2023).
- Addestrare via stim, differenze di contatto visivo o comunicazione naturale ("normalizzazione" basata sulla compliance) — aumenta il masking e il danno a lungo termine (F. Murray, 2023; Raymaker et al., 2020).

- Inquadrare gli interessi speciali come "ossessioni" da limitare; ridurre l'accesso all'interesse (Mantzalas et al., 2022).
 - Imporre routine/aspettative *sulla* persona piuttosto che co-crearle (F. Murray, 2022).
 - Usare linguaggio basato sul deficit e patologizzante; attribuire tutti i problemi di interazione alla persona autistica (Milton, 2012).
 - Trattare il burnout autistico come depressione o pigrizia; spingere la persona a mascherare di più (Raymaker et al., 2020).
 - Cliniche ostili sensorialmente, procedure a sorpresa e istruzioni vaghe (PMC11305600; AASPIRE).
 - Presumere che le differenze lifelong di un adulto più anziano siano "solo invecchiamento" o demenza senza una valutazione adeguata (Klein et al., 2024).
-

Parte 6 — Questioni aperte e caveats di evidenza (per una pratica onesta)

1. **La vecchiaia è una lacuna di ricerca.** Gran parte della guida sull'arco di vita per gli anziani è estrapolata; autismo + demenza, autismo + menopausa/andropausa e cure di fine vita sono in larga parte non studiati (Klein et al., 2024). Siate trasparenti sull'incertezza con i pazienti e le famiglie.
2. **Il monotropismo è descrittivo, non ancora meccanicistico o pienamente testato.** È un'ottima euristica clinica con crescente supporto convergente, ma non una diagnosi né una teoria completa (Dwyer, 2021; 2025).
3. **Non tutte le persone autistiche sono monotropiche.** Una minoranza non si riconosce nel quadro; mettete sempre al centro l'individuo (monotropism.org).
4. **L'intersezionalità è poco affrontata.** Gran parte della ricerca è bianca, occidentale, verbale e con bias verso bisogni di supporto inferiori; presentazioni, diagnosi e bisogni differiscono tra genere, razza, profilo di abilità intellettuale e comunicazione (limiti in Raymaker et al., 2020).
5. **La co-occorrenza è la regola.** ADHD (AuDHD), ansia, depressione, differenze di apprendimento, condizioni GI/del sonno co-occorrono

comunemente; il monotropismo può aiutare a spiegare la sovrapposizione AuDHD, e i punteggi del Monotropism Questionnaire sono più alti nell'AuDHD (Garau et al., 2023; NAS, 2025).

Fonti

1. Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism. *Autism*, 9(2), 139–156.
<https://doi.org/10.1177/1362361305051398> — via <https://monotropism.org/murray-lesser-lawson>
2. Murray, F. (2018, aggiornato 2025). Me and Monotropism: a unified theory of autism. *The Psychologist*, BPS.
<https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism>
3. Murray, F. (2023). Monotropism and Wellbeing (keynote, Scottish Autism Research Group 2023). <https://monotropism.org/wellbeing>
4. Murray, F. (2019). Monotropism at School (originariamente in *Tes*).
<https://monotropism.org/school/> — indicizzato a <https://monotropism.org/in-practice>
5. Murray, F. (2022). Understanding how routines can help autistic people thrive. *Thinking Person's Guide to Autism*.
<https://thinkingautismguide.com/2022/04/understanding-how-routines-can-help-autistic-people.html>
6. National Autistic Society (Edgar, H. & Adkin, T., 2025). What is monotropism? Understanding a neuroaffirming theory of autism.
<https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/what-is-monotropism>
7. Dwyer, P. (2021). Revisiting monotropism. *Autistic Scholar*.
<https://www.autisticscholar.com/monotropism/>
8. Dwyer, P. (2025). Monotropism: between obsessive joy and overwhelm. OTARC Blog, La Trobe University.
<https://otarc.blogs.latrobe.edu.au/monotropism-between-obsessive-joy-and-overwhelm>
9. Garau, V. et al. (2023). Development and validation of a novel self-report measure of monotropism (the Monotropism Questionnaire). OSF preprint. <https://osf.io/ft73y/> — strumento a <https://dlcincluded.github.io/MQ/>

10. Landry, R. & Bryson, S. (2004). Impaired disengagement of attention in young children with autism. *J Child Psychol Psychiatry*, 45(6), 1115–1122. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00304.x>
11. Sacrey, L.-A. et al. (2015). Attention disengagement in autism spectrum disorder: a meta-analysis. *Neurosci Biobehav Rev*, 56, 111–121. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.10.011>
12. Heasman, T. et al. (2024). Autistic flow theory. (Citato in NAS, 2025.)
13. Raymaker, D. M. et al. (2020). "Having all of your internal resources exhausted beyond measure and being left with no clean-up crew": defining autistic burnout. *Autism in Adulthood*, 2(2), 132–143. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32851204> — testo completo: https://pdxscholar.library.pdx.edu/socwork_fac/378
14. Mantzalas, J. et al. (2022). A conceptual model of risk and protective factors for autistic burnout. *Autism Research*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aur.2722>
15. Pearson, A. & Rose, K. (2021). A conceptual analysis of autistic masking: understanding the narrative of stigma and the illusion of choice. *Autism in Adulthood*, 3(1). <https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/aut.2020.0043>
16. Bradley, L. et al. (2021). Autistic adults' experiences of camouflaging and its perceived impact on mental health. *Autism in Adulthood*, 3(4), 320–329. (PubMed 36601637.)
17. Milton, D. (2012). On the epistemic and ontological value of the double empathy problem. *Dis & Soc*. Sintesi: Reframing Autism, <https://reframingautism.org.au/miltons-double-empathy-problem-a-summary-for-non-academics>
18. Lawson, W. (2011). *The Passionate Mind: How People with Autism Learn*. Jessica Kingsley. — e Lawson, W. (2025). Research by autistic researchers: an 'insider's view' into autism. *Frontiers in Psychiatry*, 16, 1664507. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12586063/>
19. Wood, R. (2019). Autism, intense interests and support in school: from wasted efforts to shared understandings. *Educational Studies*. Sintesi: <https://woodbug.blog/2019/03/27/autistic-children-and-intense-interests-the-key-to-their-educational-inclusion/>
20. Wood, R. et al. (2022). *Learning From Autistic Teachers*. Jessica Kingsley.

21. Leatherland, J. (2019). Understanding how autistic pupils experience secondary school (tesi di dottorato, Sheffield Hallam).
<http://shura.shu.ac.uk/23231/>
22. Kasari, C., Freeman, S., & Paparella, T. (2006). Joint attention and symbolic play in young children with autism: a randomized controlled intervention study. *J Child Psychol Psychiatry*, 47, 611–620. (Riferito via PMC5683273.)
23. Donzelli, S. (2021). Autistic play at forest school: pretend play characteristics seen otherwise. *Forest School Association*.
<https://forestschoollassociation.org/autistic-play-at-forest-school-pretend-play-characteristics-seen-otherwise/>
24. Hallett, S. (2021). Loops of concern (guida sulla ruminazione autistica).
<https://medium.com/@sonyahallett/loops-of-concern-ff792eebad03>
25. Kelly Mahler (2024). Interoception and monotropism.
<https://www.kelly-mahler.com/resources/blog/interoception-and-monotropism-paying-attention-to-autistic-adhd-experiences/>
26. Knight, J. (2021). Staying put, monotropism & me (tunnels not tasks); (2022) Applying monotropism.
<https://spacedoutandsmiling.com/blog/2021-11-27-staying-put-monotropism-me>
27. Booth, J. (2021). Why does work not work for autistic people?
<https://janinebooth.com/content/why-does-work-not-work-autistic-people>
28. BERA (2021). Autism: the benefits of monotropism and flow states and its applications for the classroom. <https://www.bera.ac.uk/blog/autism-the-benefits-of-monotropism-and-flow-states-and-its-applications-for-the-classroom>
29. Autism Society (2025). Autistic meltdowns and shutdowns (scheda informativa). <https://autismsociety.org/>
30. Leicestershire Partnership NHS Trust — Autism Space. Understanding autistic meltdowns and shutdowns.
<https://www.leicspart.nhs.uk/autism-space/health-and-lifestyle/meltdowns-and-shutdowns>
31. Reframing Autism. All about autistic shutdowns: a guide for allies.
<https://reframingautism.org.au/all-about-autistic-shutdown-guide-for-allies>

32. AASPIRE Healthcare Toolkit / Autism Healthcare Accommodations Tool (AHAT). <https://autismandhealth.org>
33. Children's Hospital of Philadelphia (CHOP). Tips for more positive office visits for patients with ASD. <https://www.chop.edu/news/tips-more-positive-office-visits-patients-asd>
34. UNC Health (2025). Autistic patients need better care, accommodations in the medical office. <https://news.unchealthcare.org/2025/04/autistic-patients-need-better-care-accomodations-in-the-medical-office>
35. Autism Spectrum News. Creating sensory-friendly health care environments for autistic patients. <https://autismspectrumnews.org/creating-sensory-friendly-health-care-environments-for-autistic-patients>
36. Klein, C. B. et al. (2024). Aging well and autism: a narrative review and recommendations for future research. *Healthcare*, 12(12), 1207. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11203987> — <https://doi.org/10.3390/healthcare12121207>
37. Organization for Autism Research (OAR). Aging on the autism spectrum. <https://researchautism.org/oaracle-newsletter/aging-on-the-autism-spectrum>
38. Lai, M.-C. & Baron-Cohen, S. (2015). Identifying the lost generation of adults with autism spectrum conditions. *Lancet Psychiatry*. (Riferito in Klein et al., 2024.)
39. Edgar, H. (2023). Supporting pupils through autistic burnout (guida per insegnanti). <https://autisticrealms.com/supporting-pupils-through-autistic-burnout-teacher-guide/>
40. Edgar, H. (2024). Autistic young people: skills regression, burnout or a shift in monotropic attentional resources? <https://autisticrealms.com/autistic-young-people-skills-regression-burnout-or-a-shift-in-monotropic-attentional-resources/>
41. Autism Awareness Australia. Understanding mental health in autistic teenagers. <https://www.autismawareness.com.au/navigating-autism/understanding-mental-health-in-autistic-teenagers>
42. Autism Research Institute (ARI). Understanding and supporting puberty in autistic girls and boys. <https://autism.org/understanding-and-supporting-puberty>
43. Neurodivergent Insights. Autism and the double empathy problem in medicine. <https://neurodivergentinsights.com/the-double-empathy->

[problem-in-medicine](#)

44. PieBru (2025). Monotropism: an interest-based account of autism (breve di fonte).
<https://github.com/PieBru/monotropism/blob/main/monotropism.md>
45. Revisione narrativa: Autism-friendly healthcare — a narrative review of the literature (PMC11305600).
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11305600>

Risorse pratiche di supporto (citate in linea sopra per affermazioni pratiche a basse poste)

- Advanced Autism Services (2025). How to support autistic adults in the workplace. <https://www.advancedautism.com/post/how-to-support-autistic-adults-in-the-workplace>
- Sachs Center. Autism workplace accommodations that actually work. <https://sachscenter.com/autism-workplace-accommodations>
- Links ABA. Accessing healthcare as an autistic individual; work and mental health tips for autistic adults. <https://linksaba.com>
- Autism Little Learners. Transitions and autism; smoother transitions in young autistic kids. <https://autismlittlelearners.com>
- Grateful Care ABA. Preparing for doctor visits with autism. <https://www.gratefulcareaba.com/blog/preparing-for-doctor-visits-with-autism>
- ABTAB / Above and Beyond Therapy. Autism aging out; autism shutdown. <https://www.abtaba.com>
- Additude. Aging with autism: cognition, health, loneliness & other factors. <https://www.additudemag.com/aging-with-autism-research>
- Retireguide. Aging with autism: a seniors & caregivers guide. <https://www.retireguide.com/guides/seniors-autism-spectrum>
- Raising Children Network (Australia). Self-identity for your autistic teen. <https://raisingchildren.net.au/autism>
- Autistic Realms (Edgar, H.). Monotropism = happy flow state. <https://autisticrealms.com/monotropism-happy-flow-state>

- Neurodiverse Connection. Embracing autistic children's monotropic flow states. <https://ndconnection.co.uk/blog/embracing-autistic-childrens-monotropic-flow-states>